

Разрывы промежности III и IV степени

Информация для пациента · Тяжёлые послеродовые разрывы — восстановление и заживление

WARWIKI

При вагинальных родах область между влагалищем и анусом (промежность) может разорваться. **Разрыв III степени** распространяется на мышцу анального сфинктера; **разрыв IV степени** проходит через сфинктер в слизистую прямой кишки. Вместе они называются **OASIS**. Разрывы ушиваются сразу после родов, и при правильном уходе большинство пациенток полностью восстанавливаются.

Что произошло

Анальный сфинктер — кольцо мышц, удерживающих газы и стул. Тяжёлый разрыв затрагивает эту мышцу, поэтому тщательное ушивание и наблюдение важны для сохранения контроля над кишечником в будущем. Разрыв не является вашей ошибкой и не связан с вашими действиями.

Операция по ушиванию

Ушивание выполняется вскоре после родов, как правило, в операционной или родовом зале под адекватной анестезией (чаще всего спинальной или эпидуральной). Хирург восстанавливает ткани **послойно** — сшивает мышцу сфинктера и, при разрыве IV степени, слизистую прямой кишки — рассасывающимися швами. Вам назначат антибиотики, обезболивание и рекомендации по уходу за кишечником.

ТЕРМИНЫ

Промежность

Область между влагалищем и анусом.

OASIS

Акушерская травма анального сфинктера — разрыв III или IV степени.

Анальный сфинктер

Мышечное кольцо, контролирующее газы и стул.

III степень

Разрыв, достигающий мышцы анального сфинктера.

IV степень

Разрыв через сфинктер в слизистую прямой кишки.

Размягчитель стула

Препарат, предотвращающий твёрдый стул и натуживание в период заживления.

ЛФК тазового дна

Физиотерапия для восстановления силы и координации мышц после заживления.

ОСТАНУТСЯ ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ? Большинство пациенток полностью восстанавливаются и сохраняют нормальный контроль над кишечником. У части могут возникать эпизоды недержания газов или стула — именно поэтому важны наблюдение и ЛФК тазового дна. При симптомах существуют эффективные методы лечения. Сообщайте своему врачу о любом недержании, не откладывая.

Заживление и уход

- 1 Мягкий стул** — принимайте назначенный размягчитель стула, пейте достаточно жидкости и ешьте продукты с клетчаткой, чтобы не натуживаться.
- 2 Обезболивание и гигиена** — используйте назначенные обезболивающие, промывайте промежность тёплой водой после туалета, содержите область чистой и сухой.
- 3 Покой** — избегайте подъёма тяжестей, кроме вашего ребёнка; постепенное улучшение наступает в течение нескольких недель.
- 4 ЛФК тазового дна** — помогает восстановить силу мышц после первичного заживления.

Наблюдение и будущие роды

- Врач проверит состояние швов и функцию кишечника на контрольном визите.
- Обсудите **следующие роды** — врач порекомендует оптимальный способ родоразрешения.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Повышение температуры, усиление боли или зловонные выделения** (возможная инфекция)
- Признаки **расхождения швов**
- **Недержание газов или стула** или новые трудности с их удержанием
- Тяжёлый запор или невозможность опорожнить кишечник

Полезные советы

- Сидите удобно (подушка поможет); в первые дни прикладывайте лёд для уменьшения отёка.
- Не вводите ничего в прямую кишку (свечи, клизмы) без разрешения врача.

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

- 1. Разрыв III или IV степени (OASIS)** затрагивает анальный сфинктер и ушивается послойно сразу после родов.
- 2. Следите за мягкостью стула,** ухаживайте за швами и занимайтесь ЛФК тазового дна — большинство пациенток восстанавливается полностью.
- 3. Сообщайте врачу о любом** недержании газов или стула, повышении температуры или расхождении швов — раннее обращение улучшает исходы.